CAC
Cuenta de Alto Costo

3

Cáncer de próstata

RESUMEN infográfico

Cáncer de próstata

2 de enero de 2024 al 1° de enero de 2025

3

Morbimortalidad del cáncer de próstata

Ocupó el **segundo lugar** entre los 11 tipos de cáncer priorizados y el primero en la población masculina con el 50,23 % del total de los casos nuevos en los **hombres.**

Se notificaron **7.288** **casos nuevos invasivos** lo que corresponde a una PCNR estandarizada de 25,87 casos nuevos por cada 100.000 hombres (IC 95 %: 25,28 - 26,47).

Se registraron **4.107** **muertes por todas las causas** en los hombres con cáncer invasivo, lo que representa una mortalidad estandarizada de 14,32 fallecimientos por cada 100.000 hombres (IC 95 %: 13,88 – 14,76).

El número total de casos nuevos, prevalentes y fallecidos en el periodo fue de 7.297, 81.423 y 4.107, respectivamente.

Caracterización de los casos nuevos de cáncer de próstata

La mediana de la edad fue de 70 años (RIC: 65 – 76).

La terapia sistémica fue el tratamiento más frecuente.

En el país, la estadificación TNM se realizó en el 83,57 % de los CNR.

Evaluación de la gestión del riesgo en los casos de cáncer de próstata

En 2025, la oportunidad diagnóstica continúa con una tendencia al aumento, llegando a 92,64 días en promedio. Entre el régimen contributivo y subsidiado hubo una diferencia de 26,37 días entre los promedios

Se continúan presentando dificultades para la detección temprana de este cáncer, solo el **56,17 %** fueron diagnosticados en estadios 0, I y II.

Descargar infografía

PCNR: proporción de casos nuevos reportados.
IC: intervalo de confianza.
CNR: casos nuevos reportados.
RIC: rango intercuartílico.

3. Cáncer de próstata

CIE10: C61, D075; CIE-O-3: C61

3.1. Morbimortalidad del cáncer de próstata

El cáncer de próstata ocupó el segundo lugar en frecuencia de casos nuevos, entre las 11 neoplasias priorizadas para el seguimiento por la Cuenta de Alto Costo (CAC), superado únicamente por el cáncer de mama. En la población masculina, continúa siendo la neoplasia más común, al concentrar el 50,23 % de los CNR. Durante el periodo analizado – según el código CIE-10 - se identificaron 7.297 casos *in situ* e invasivos de los cuales solo el 0,12 % (n= 9) correspondió a lesiones *in situ*. En cuanto a la mortalidad, se reportaron 4.107 fallecimientos por todas las causas en las personas diagnosticadas con esta neoplasia **(tabla 3.1).**

Tabla 3.1. Medidas de frecuencia del cáncer de próstata en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

Medida	Casos[1]	Medida cruda[2,3]	Medida estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
PCNR	7.288	28,27	25,87	(25,28 - 26,47)
Prevalencia	81.243	315,87	287,21	(285,24 - 289,19)
Mortalidad[6]	4.107	15,93	14,32	(13,88 - 14,76)

[1] Incluye todos los casos de cáncer de próstata invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Informados por 100.000 hombres.
[3] La población de referencia corresponde a la proyectada por el DANE para el año 2024.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
[6] **Mortalidad general:** corresponde a los casos fallecidos por todas las causas, de la cohorte en seguimiento por la CAC.
PCNR: proporción de casos nuevos reportados; **IC:** intervalo de confianza.

3.1.1. PCNR de cáncer de próstata según la región y la entidad territorial

La región del país con la PCNR estandarizada más alta fue Bogotá, D. C., con un valor superior al nacional. En contraste, la más baja se registró en Amazonía-Orinoquía **(tabla 3.2).** En cuanto a las entidades territoriales, después de Bogotá, D. C., San Andrés, Providencia y Santa Catalina, presentó la segunda cifra más alta, con 63,96 casos por 100.000 hombres (IC 95 %: 40,17 - 97,25). Por su parte, el valor más bajo se registró en Vichada, con 2,69 casos por 100.000 hombres (IC 95 %: 0,07 - 12,98). Durante el periodo analizado, Guainía y Vaupés no reportaron casos nuevos de cáncer de próstata.

Para conocer esta información con mayor desagregación, le invitamos a consultar HIGIA.

Tabla 3.2. PCNR de cáncer de próstata según la región de residencia en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

Región	CNR[1]	Denominador[2]	PCNR cruda[3]	PCNR estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Amazonía-Orinoquía	63	782.827	8,05	10,70	(8,21 - 13,66)
Bogotá, D. C.	1.728	3.830.128	45,12	42,12	(40,16 - 44,16)
Caribe	1.816	6.001.874	30,26	32,55	(31,07 - 34,09)
Central	1.654	6.085.723	27,18	21,97	(20,93 - 23,06)
Oriental	1.047	4.933.800	21,22	18,91	(17,78 - 20,09)
Pacífica	980	4.143.246	23,65	20,22	(18,98 - 21,54)
Nacional	**7.288**	**25.777.598**	**28,27**	**25,87**	**(25,28 - 26,47)**

[1] Incluye todos los casos nuevos de cáncer de próstata invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Corresponde a la población proyectada por el DANE para el año 2024.
[3] La PCNR es informada por 100.000 hombres.
[4] Estandarización por la edad con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
CNR: casos nuevos reportados; **PCNR:** proporción de casos nuevos reportados; **IC:** intervalo de confianza.

3.1.2. PCNR de cáncer de próstata según el régimen del aseguramiento y la entidad aseguradora

La PCNR estandarizada fue significativamente mayor en los regímenes contributivo y especial en comparación con el subsidiado **(tabla 3.3).** Adicionalmente, se informaron cuatro casos nuevos en las secretarías de salud y 7 en los Planes voluntarios de salud.

En cuanto a las EAPB, las PCNR estandarizadas más altas se observaron en la EPS047, la RES012 y la EAS016 con 112,69, 107,82 y 100,02 casos por 100.000 hombres afiliados, respectivamente. Por otra parte, las más bajas se identificaron en la EPS025, la ESS062 y la RES008, cada una con 1,84, 3,65 y 6,72, en ese orden. Por su parte, la EPSI03 y la EPSI06 no reportaron nuevos diagnósticos en el periodo; ambas entidades prestan atención en salud a la población indígena.

La información completa de las EAPB está disponible en HIGIA.

Tabla 3.3. PCNR de cáncer de próstata según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

Régimen	CNR[1]	Denominador[2]	PCNR cruda[3]	PCNR estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Contributivo	4.962	13.978.087	35,50	29,19	(28,38 - 30,02)
Subsidiado	1.939	9.876.813	19,63	14,73	(14,08 - 15,40)
Excepción	351	1.109.205	31,64	22,50	(20,19 - 25,03)
Especial	25	18.792	133,04	25,86	(15,56 - 76,55)
Planes voluntarios de salud	7	SD	SD	SD	SD
No asegurado	4	SD	SD	SD	SD

[1] Incluye todos los casos nuevos de cáncer de próstata invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Corresponde a la población de la BDUA con corte al 30 de junio de 2024.
[3] La PCNR es informada por 100.000 hombres afiliados.
[4] Estandarización por la edad con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
En la población no asegurada y los planes voluntarios de salud, no se cuenta con la información para establecer el denominador, por lo cual solamente se presenta el número de CNR.
CNR: casos nuevos reportados; **PCNR:** proporción de casos nuevos reportados; **IC:** intervalo de confianza; **SD:** sin dato.

3.1.3. Prevalencia del cáncer de próstata según la región y la entidad territorial

Las regiones del país con la prevalencia estandarizada más alta fueron Bogotá, D. C., y la Central. En contraste, la medida más baja se presentó en la Amazonía-Orinoquía **(tabla 3.4).** Al analizar las entidades territoriales, San Andrés, Providencia y Santa Catalina presentó una cifra superior a la de Bogotá, D. C., con 613,89 casos por 100.000 hombres (IC 95 %: 528,78 - 708,74). Por su parte, Vaupés presentó la menor prevalencia estandarizada, con 7,59 casos por 100.000 hombres (IC 95 %: 0,19 - 39,27).

Para conocer esta información con mayor desagregación, le invitamos a consultar HIGIA.

Tabla 3.4. Prevalencia del cáncer de próstata según la región de residencia en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

Región	Casos[1]	Denominador[2]	Prevalencia cruda[3]	Prevalencia estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Amazonía-Orinoquía	617	782.827	78,82	106,72	(98,45 - 115,46)
Bogotá, D. C.	18.726	3.830.128	488,91	465,94	(459,28 - 472,68)
Caribe	14.943	6.001.874	248,97	267,86	(263,58 - 272,19)
Central	22.017	6.085.723	361,78	290,64	(286,81 - 294,51)
Oriental	12.130	4.933.800	245,86	217,44	(213,59 - 221,35)
Pacífica	12.990	4.143.246	313,52	258,82	(254,37 - 263,33)
Nacional	**81.423**	**25.777.598**	**315,87**	**287,21**	**(285,24 - 289,19)**

[1] Incluye todos los casos de cáncer de próstata invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Corresponde a la población proyectada por el DANE para el año 2024.
[3] La prevalencia es informada por 100.000 hombres.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
IC: intervalo de confianza.

3.1.4. Prevalencia del cáncer de próstata según el régimen del aseguramiento y la entidad aseguradora

Según el régimen de aseguramiento, la prevalencia estandarizada fue más alta en los regímenes especial y de excepción **(tabla 3.5),** mientras que el valor más bajo correspondió al régimen subsidiado.

Por lo que corresponde a las entidades, la EAS016, la RES012 y la RES002 registraron las mayores prevalencias, con 896,50, 714,64 y 703,98 casos por cada 100.000 hombres afiliados, respectivamente. Por otro lado, las cifras más bajas se observaron en la EPSI03 (50,93), la EPSI06 (55,73) y la EPSI04 (58,89).

La información completa de las EAPB está disponible en HIGIA.

Tabla 3.5. Prevalencia del cáncer de próstata según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

Región	Casos[1]	Denominador[2]	Prevalencia cruda[3]	Prevalencia estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Contributivo	58.634	13.978.087	419,47	346,32	(343,52 - 349,13)
Subsidiado	15.765	9.876.813	159,62	115,76	(113,95 - 117,60)
Excepción	5.780	1.109.205	521,09	357,42	(348,21 - 366,85)
Especial	378	18.792	2.011,49	383,99	(339,14 - 452,55)
Planes voluntarios de salud	70	SD	SD	SD	SD
No asegurado	19	SD	SD	SD	SD
Entidades liquidadas	777	SD	SD	SD	SD

[1] Incluye todos los casos de cáncer de próstata invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Corresponde a la población de la BDUA con corte al 30 de junio de 2024.
[3] La prevalencia es informada por 100.000 hombres afiliados.
[4] Estandarización por la edad con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
En la población no asegurada, los planes voluntarios de salud y en las entidades liquidadas, no se cuenta con la información para establecer el denominador, por lo cual solamente se presenta el número de casos notificados.
IC: intervalo de confianza; **SD:** sin dato.

3.1.5. Mortalidad del cáncer de próstata según la región y la entidad territorial

Para la cohorte en seguimiento, la región Amazonía-Orinoquía presentó la menor mortalidad por todas las causas estandarizada entre las regiones analizadas. Sin embargo, la interpretación de este hallazgo debe considerar el número de fallecimientos y el tamaño de la población de referencia de la región. Estas condiciones pueden dar lugar a estimaciones con menor precisión e intervalos de confianza más amplios, por lo que los resultados no permiten concluir un comportamiento más favorable de la mortalidad en comparación con las demás regiones.

Dentro de las mediciones más altas están Bogotá, D. C., y el Caribe. Entre estas hubo una diferencia absoluta fue de 4,26 muertes por 100.000 hombres, lo que representa una cifra mayor de 1,26 veces en Bogotá, D. C., respecto a la observada en el Caribe.

Según el ente territorial de residencia, después de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que registró ocho fallecimientos durante el periodo evaluado, y de Bogotá, D. C., la mayor mortalidad general se observó en el Atlántico, con 20,11 muertes por cada 100.000 hombres (IC 95 %: 18,73 - 21,57; n= 246). Mientras que la mortalidad general más baja se presentó en Guainía. Sin embargo, debido a que solo reportó un caso, su precisión es limitada. Por lo tanto, la segunda entidad territorial con la mortalidad más baja fue Caldas con 7,26 muertes por 100.000 hombres (5,50 – 9,49; n= 57).

Además, el departamento del Amazonas, con 28 casos prevalentes, no presentó defunciones durante este periodo.

Para conocer esta información con mayor desagregación, le invitamos a consultar HIGIA.

Tabla 3.6. Mortalidad general del cáncer de próstata según la región de residencia en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

Región	Muertes[1]	Denominador[2]	Mortalidad cruda[3]	Mortalidad estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Amazonía-Orinoquía	50	782.827	6,39	8,75	(6,49 - 11,50)
Bogotá, D. C.	791	3.830.128	20,65	20,11	(18,73 - 21,57)
Caribe	890	6.001.874	14,83	15,85	(14,83 - 16,93)
Central	1.040	6.085.723	17,09	13,60	(12,79 - 14,46)
Oriental	627	4.933.800	12,71	11,07	(10,22 - 11,98)
Pacífica	709	4.143.246	17,11	13,59	(12,60 - 14,63)
Nacional	**4.107**	**25.777.598**	**15,93**	**14,32**	**(13,88 - 14,76)**

[1] Incluye las muertes por todas las causas en la población con cáncer de próstata invasivo, de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Corresponde a la población proyectada por el DANE para el año 2024.
[3] La mortalidad es informada por 100.000 hombres.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
IC: intervalo de confianza.

3.1.6. Mortalidad del cáncer de próstata según el régimen del aseguramiento y la entidad aseguradora

Entre los regímenes de afiliación, la mortalidad estandarizada fue mayor en el régimen contributivo que en el subsidiado. No obstante, este hallazgo no implica que el régimen del aseguramiento constituya, por sí mismo, un factor de riesgo para la mortalidad. Las diferencias observadas podrían estar influenciadas por otros factores.

En cuanto a las entidades, con más de cinco muertes en el periodo, la mortalidad más alta fue la para la EPS042, del contributivo, con 33,28 muertes por 100.000 hombres afiliados (IC 95 %: 20,00 – 52,79; n= 19). Por su parte, las medidas de mortalidad estandarizada más bajas se estimaron en las EPS indígenas del régimen subsidiado EPSI04 y EPSI03, con 3,50 (IC 95 %: 1,06 - 8,77; n= 5) y 5,27 muertes por 100.000 hombres afiliados (IC 95 %: 3,00 - 8,65; n= 16), respectivamente.

La información completa de las EAPB está disponible en HIGIA.

Tabla 3.7. Mortalidad general del cáncer de próstata según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

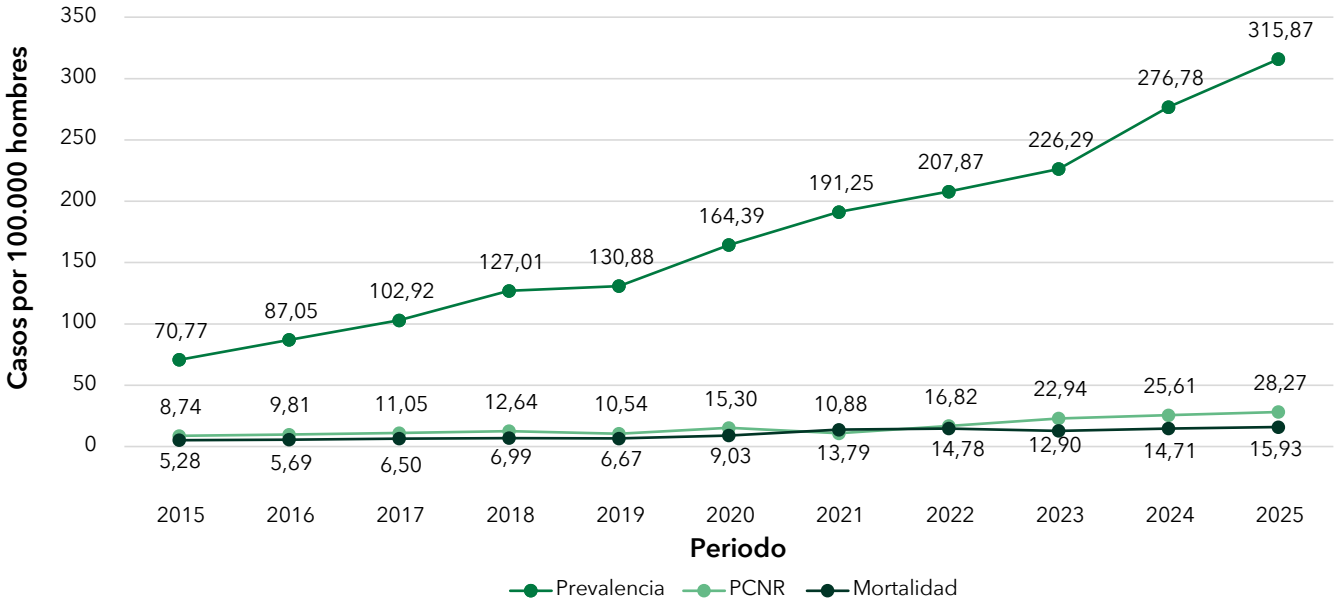
Régimen	Muertes[1]	Denominador[2]	Mortalidad cruda[3]	Mortalidad estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Contributivo	2.608	13.978.087	18,66	15,41	(14,83 - 16,02)
Subsidiado	1.221	9.876.813	12,36	8,57	(8,09 - 9,07)
Excepción	178	1.109.205	16,05	10,54	(9,04 - 12,26)
Especial	10	18.792	53,21	7,98	(3,74 - 60,69)
Planes voluntarios de salud	1	SD	SD	SD	SD
No asegurado	0	SD	SD	SD	SD
Entidades liquidadas	89	SD	SD	SD	SD

[1] Incluye las muertes por todas las causas en la población con cáncer de próstata invasivo, de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Corresponde a la población de la BDUA con corte al 30 de junio de 2024.
[3] La mortalidad es informada por 100.000 hombres afiliados.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
En la población no asegurada, los planes voluntarios de salud y en las entidades liquidadas, no se cuenta con la información para establecer el denominador, por lo cual solamente se presenta el número de fallecidos notificados.
IC: intervalo de confianza; **SD:** sin dato.

3.1.7. Evolución del registro de cáncer de próstata en el aseguramiento en Colombia

Como se observa en la **figura 3.1,** el cáncer de próstata ha presentado una tendencia ascendente en los tres indicadores de morbimortalidad. Para 2025, la prevalencia y la PCNR registraron aumentos relativos de 14,12 % y 10,38 %, respectivamente, en comparación con el periodo anterior. En cuanto a la mortalidad general, se observó un incremento de 1,22 muertes por cada 100.000 hombres.

Figura 3.1. Tendencia de las medidas de frecuencia del cáncer de próstata en el marco del aseguramiento, Colombia 2015 - 2025



Incluye los casos con cáncer de próstata invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
Las medidas presentadas corresponden a valores crudos, reportados por 100.000 hombres.
Mortalidad general: corresponde a los casos fallecidos por todas las causas, de la cohorte en seguimiento por la CAC.
PCNR: proporción de casos nuevos reportados.

Descargar figura

3.2. Caracterización de los casos nuevos de cáncer de próstata

3.2.1. Características sociodemográficas de los casos nuevos de cáncer de próstata

En la caracterización sociodemográfica de los casos nuevos de cáncer de próstata, los nueve casos reportados como *in situ* correspondieron a afiliados del régimen contributivo. En el país, la mediana de la edad fue de 70 años (RIC: 65 - 76). Sin embargo, al analizarla esta medida según el régimen de aseguramiento, se observó un menor promedio de edad en los casos nuevos del contributivo y una mayor en el especial.

Respecto a la pertenencia étnica, la proporción de nuevos casos reportados en la población negra fue mayor en el contributivo que en el subsidiado. En contraste la población indígena presentó una mayor proporción en el subsidiado que en el contributivo siendo casi tres veces superior en el primero.

En cuanto a la región de residencia, el 54,66 % de los casos nuevos del régimen contributivo se concentró en Bogotá, D. C., (23,69 %) y en la región Central (22,74 %). Por su parte, en el régimen subsidiado el 49,46 % de los casos residía en la región Caribe. En los regímenes de excepción y especial, la mayoría de los casos se registró en la región Central **(tabla 3.8).**

Tabla 3.8. Caracterización sociodemográfica de los casos nuevos de cáncer de próstata reportados según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

Variables[1]	Régimen del aseguramiento				
	Contributivo	Subsidiado	Excepción	Especial	Total[2]
	n= 4.971	n= 1.939	n= 351	n= 25	n= 7.297
	(68,12 %)	(26,57 %)	(4,81 %)	(0,34 %)	(100,00 %)
Edad	69 (64 - 75)	72 (66 - 77)	71 (66 - 76)	75 (73 - 79)	70 (65 - 76)
Etnia					
Ninguna	4.758 (95,72)	1.883 (97,11)	345 (98,29)	25 (100,00)	7.022 (96,23)
Indígena	15 (0,30)	17 (0,88)	0 (0,00)	0 (0,00)	32 (0,44)
Negro	159 (3,20)	37 (1,91)	5 (1,43)	0 (0,00)	201 (2,76)
Otro[3]	39 (0,78)	2 (0,10)	1 (0,28)	0 (0,00)	42 (0,58)
Región de residencia					
Amazonía-Orinoquía	36 (0,72)	19 (0,98)	8 (2,28)	0 (0,00)	63 (0,86)
Bogotá, D. C.	1.461 (29,39)	166 (8,56)	100 (28,49)	0 (0,00)	1.729 (23,69)
Caribe	802 (16,13)	959 (49,46)	45 (12,82)	4 (16,00)	1.816 (24,89)
Central	1.256 (25,27)	280 (14,44)	109 (31,05)	11 (44,00)	1.659 (22,74)
Oriental	718 (14,44)	249 (12,84)	79 (22,51)	1 (4,00)	1.047 (14,35)
Pacífica	698 (14,04)	266 (13,72)	10 (2,85)	9 (36,00)	983 (13,47)

[1] Los valores reportados corresponden a frecuencias absolutas y relativas (n, %) para todas las variables, excepto la edad en la que se presenta le mediana (rango intercuartílico).
[2] Para los valores totales se tienen en cuenta siete casos de los planes voluntarios de salud y cuatro de la población no asegurada.
[3] Incluye población perteneciente a las etnias ROM (gitano), raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia y palenqueros de San Basilio.

3.2.2. Caracterización clínica de los casos nuevos reportados de cáncer de próstata

En la **tabla 3.9** se describen las características de los casos nuevos de cáncer de próstata según el régimen del aseguramiento al sistema de salud. En relación con la extensión de la enfermedad, clasificada mediante el código CIE-10, el 99,88 % de los tumores de próstata fueron catalogados como invasivos. En el país, la estadificación TNM se realizó en el 83,57 % de los CNR.

Entre los casos con clasificación TNM (n= 6.098), el estadio II fue el más frecuente, con el 38,47 % (n= 2.346). Por su parte, los estadios III y IV agruparon el 43,41 %. Al comparar por el régimen de aseguramiento, se observó una mayor concentración de casos en los estadios avanzados en el subsidiado, en donde los estadios III y IV representaron el 57,80 % de los casos.

En cuanto a la clasificación tumoral, se identificaron nueve casos reportados como *in situ*. Por otra parte, aunque la AJCC no establece la categoría *in situ* para el cáncer de próstata, en la variable TNM se registraron 12 casos en estadio 0. Esta diferencia podría estar relacionada con la temporalidad del registro, ya que el código CIE-10 puede asignarse en una etapa distinta del proceso diagnóstico, mientras que la clasificación TNM se registra una vez completados los estudios de extensión o al momento de definir el tratamiento.

De otra parte, el 93,33 % de los CNR contó con la clasificación de Gleason. Dentro de los clasificados, el 27,68 % se clasificó en el Grupo 1 (≤ 6), mientras que los grupos 4 y 5 (Gleason 8 – 10), asociados a la enfermedad de alto riesgo, representaron el 33,51 % de los casos, lo que refleja una mayor agresividad al momento del diagnóstico. Entre los regímenes del aseguramiento, tanto el contributivo como el subsidiado concentran la mayor proporción de casos en el grupo 1. Sin embargo, el porcentaje de casos en el grupo 4 del régimen subsidiado, fue superior en comparación con el resto del aseguramiento, lo que sugiere un mayor número de casos con enfermedad de alto riesgo.

La medición del antígeno prostático específico (PSA) al momento del diagnóstico constituye un componente central en el proceso diagnóstico, la toma de decisiones terapéuticas y la estimación del pronóstico; esta prueba se realizó en el 92,99 % de los casos diagnosticados durante el periodo. La mediana de la prueba de PSA fue mayor en los casos del régimen subsidiado (29,00 ng/mL), lo que podría asociarse con una mayor probabilidad de alto riesgo, aunque, su interpretación debe integrarse con otras variables pronósticas, particularmente con el grupo de clasificación Gleason y el estadio clínico, para una adecuada clasificación del riesgo.

En cuanto al seguimiento, el PSA fue medido posterior al tratamiento en el 56,65 % de los casos, con una mayor proporción en el régimen subsidiado.

Tabla 3.9. Caracterización clínica de los casos nuevos de cáncer de próstata reportados según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

Variables[1,2]	Régimen del aseguramiento				
	Contributivo	Subsidiado	Excepción	Especial	Total[3]
	n= 4.971	n= 1.939	n= 351	n= 25	n= 7.297
	(68,12 %)	(26,57 %)	(4,81 %)	(0,34 %)	(100,00 %)
Extensión[4]					
In situ	9 (0,18)	0 (0,00)	0 (0,00)	0 (0,00)	9 (0,12)
Invasivo	4.962 (99,82)	1.939 (100,00)	351 (100,00)	25 (100,00)	7.288 (99,88)
Estadificación (sí)[5]	4.212 (84,73)	1.583 (81,64)	275 (78,35)	21 (84,00)	6.098 (83,57)
Estadio al diagnóstico[6]					
In situ	9 (0,21)	3 (0,19)	0 (0,00)	0 (0,00)	12 (0,20)
Estadio I	850 (20,18)	185 (11,69)	55 (20,00)	3 (14,29)	1.093 (17,92)
Estadio II	1.727 (41,00)	480 (30,32)	125 (45,45)	10 (47,62)	2.346 (38,47)
Estadio III	822 (19,52)	364 (22,99)	41 (14,91)	3 (14,29)	1.230 (20,17)
Estadio IV	804 (19,09)	551 (34,81)	54 (19,64)	5 (23,81)	1.417 (23,24)
Clasificación de Gleason (sí)[7]	4.672 (93,99)	1.774 (91,49)	329 (93,73)	24 (96,00)	6.810 (93,33)
Agrupación Gleason[7]					
Grupo 1	1.341 (28,70)	474 (26,72)	65 (19,76)	4 (16,67)	1.885 (27,68)
Grupo 2	1.004 (21,49)	364 (20,52)	86 (26,14)	6 (25,00)	1.461 (21,45)
Grupo 3	797 (17,06)	300 (16,91)	78 (23,71)	5 (20,83)	1.182 (17,36)
Grupo 4	1.019 (21,81)	430 (24,24)	69 (20,97)	7 (29,17)	1.528 (22,44)
Grupo 5	511 (10,94)	206 (11,61)	31 (9,42)	2 (8,33)	754 (11,07)
PSA al diagnóstico (sí)	4.663 (94,37)	1.726 (89,48)	324 (92,57)	24 (96,00)	6.747 (92,99)
PSA (ng/ml)	12,32 (7,40 - 30,00)	29,00 (12,00-100,00)	10,41 (6,32 - 21,00)	9,5 (6,00 - 14,40)	14,43 (8,00 - 42,00)
PSA posterior al tratamiento (sí)	2.728 (54,88)	1.214 (62,61)	179 (51,00)	11 (44,00)	4.134 (56,65)
Frecuencia de la PSA postratamiento					
Una vez al año	1.590 (31,99)	761 (39,25)	97 (27,64)	6 (24,00)	2.456 (33,66)
Dos veces al año	714 (14,36)	328 (16,92)	47 (13,39)	3 (12,00)	1.092 (14,97)
Tres veces al año	328 (6,60)	94 (4,85)	30 (8,55)	1 (4,00)	453 (6,21)
Más de tres veces al año	96 (1,93)	31 (1,60)	5 (1,42)	1 (4,00)	133 (1,82)
No se le realizó/desconocido	2.243 (45,12)	725 (37,39)	172 (49,00)	14 (56,00)	3.163 (43,35)

[1] Los valores reportados corresponden a frecuencias absolutas y relativas (n, %), excepto para los valores del PSA, para los cuales se presenta la mediana (rango intercuartílico).
[2] Los valores reportados incluyen casos *in situ* e invasivos.
[3] Para los valores totales se tienen en cuenta siete casos de los planes voluntarios de salud y cuatro en la población no asegurada.
[4] Definida según el código CIE-10.
[5] Definida según la clasificación TNM (para el cáncer de próstata, *in situ* no fue establecido por el Comité Estadounidense Conjunto sobre el Cáncer [AJCC, por sus siglas en inglés], sin embargo, se tiene el reporte de casos en estadio 0).
[6] Incluye todos los casos nuevos de cáncer de próstata que fueron estadificados.
[7] **Grupo 1:** Gleason ≤ 6, **grupo 2:** Gleason 3 + 4 = 7 (el primer valor determina el patrón principal de crecimiento celular), **grupo 3:** Gleason 4 + 3 = 7, **grupo 4:** Gleason 8 y **grupo 5:** Gleason 9 - 10.
PSA: antígeno prostático específico.

3.2.3. Caracterización del tratamiento en los casos nuevos de cáncer de próstata

La **tabla 3.10** muestra que, de los casos nuevos reportados, el 78,57 % (n= 5.733) recibió algún tratamiento para el cáncer de próstata. Según la estadificación TNM, el estadio con mayor acceso a los tratamientos durante el periodo, fueron aquellos diagnosticados en el estadio IV, mientras que entre los 1.199 casos con TNM desconocido el 57,63 % recibieron algún tratamiento.

Durante el periodo analizado, la terapia sistémica constituyó la modalidad terapéutica utilizada con mayor frecuencia y predominó en los estadios III y IV. En contraste, el abordaje quirúrgico fue principalmente empleado en los casos *in situ* y en el estadio I. La radioterapia fue la segunda modalidad terapéutica con mayor frecuencia de uso en los estadios III y IV **(tabla 3.10).**

Por otra parte, de los 7.297 casos nuevos de cáncer de próstata reportados, el 21,43 % (n= 1.564) no registró prescripción de tratamiento.

La mediana de edad de estos casos fue de 69 años (RIC: 64 - 75). En cuanto al puntaje de Gleason, este se reportó en el 92,84 % de los casos que no recibieron tratamiento durante el periodo analizado. Entre ellos, el 37,18 % correspondió al grupo 1, seguido del grupo 2 con el 17,95 %. Los grupos 3, 4 y 5 representaron el 13,33 %, 16,73 % y 7,88 %, respectivamente.

Respecto a la determinación del PSA, esta se realizó en el 99,04 % de los casos. La mediana del resultado fue de 12,66 ng/ml (RIC: 7,39 - 39).

Dentro de este grupo, el 32,48 % (n= 508) no contaba con información de estadificación TNM, el 33,44 % (n= 523) correspondía a diagnósticos recientes (90 días o menos, previos a la fecha de corte) y el 10,93 % (n= 171) recibió atenciones por cuidados paliativos. Estos hallazgos podrían explicar la ausencia en el manejo terapéutico la cual puede estar relacionada con limitaciones en la información clínica, la temporalidad del diagnóstico o la orientación del manejo hacia objetivos paliativos.

Tabla 3.10. Frecuencia del tratamiento prescrito en los casos nuevos de cáncer de próstata según el estadio clínico en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

Variables[1]	Estadio al diagnóstico						
	In situ	Estadio I	Estadio II	Estadio III	Estadio IV	Desconocido	Total
	n= 12	n= 1.093	n= 2.346	n= 1.230	n= 1.417	n= 1.199	n= 7.297
	(0,16 %)	(14,98 %)	(32,15 %)	(16,86 %)	(19,42 %)	(16,43 %)	(100,00 %)
Casos de recibieron algún tratamiento	10 (83,33)	779 (71,27)	1.890 (80,56)	1.042 (84,72)	1.321 (93,23)	691 (57,63)	5.733(78,57)
Tipo de tratamientos prescritos[2]							
Terapia sistémica[3]	0 (0,00)	293 (37,61)	1.031 (54,55)	798 (76,58)	1.178 (89,17)	441 (63,82)	3.741 (65,25)
Cirugía	9 (90,00)	443 (56,87)	869 (45,98)	287 (27,54)	336 (25,44)	241 (34,88)	2.185 (38,11)
Radioterapia	1 (10,00)	201 (25,80)	566 (29,95)	368 (35,32)	361 (27,33)	145 (20,98)	1.642 (28,64)

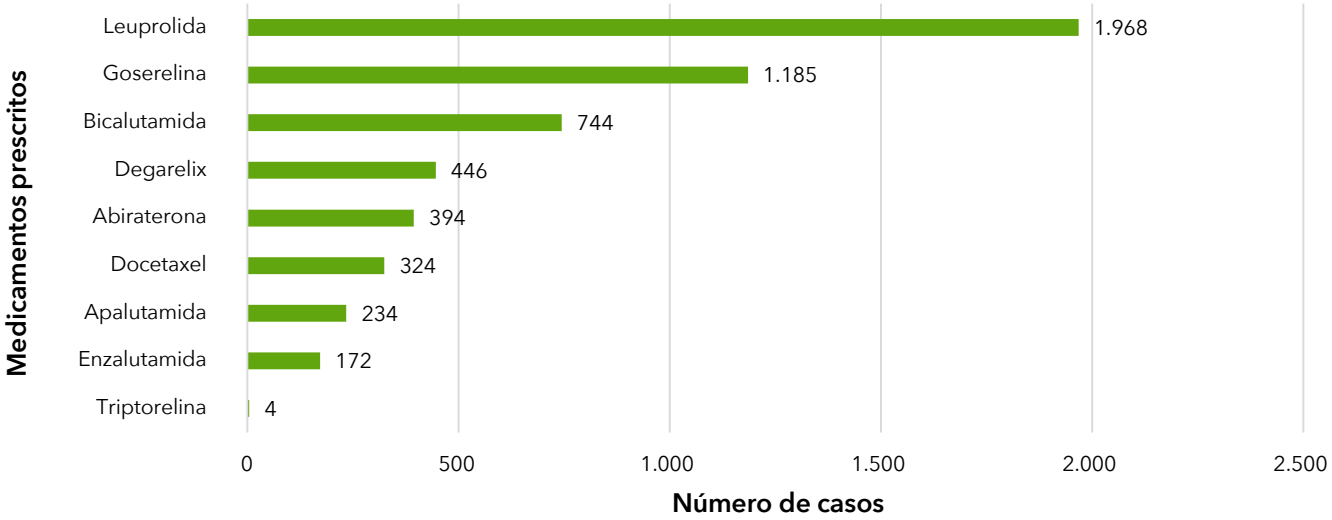
[1] Los valores reportados corresponden a frecuencias absolutas y relativas (n, %) para todas las variables.
[2] El tipo de tratamiento no es mutuamente excluyente; un mismo paciente pudo haber recibido más de un tipo de terapia.
[3] En este grupo se incluyen la quimioterapia y otras terapias sistémicas.

Enseguida, la **figura 3.2** muestra los medicamentos administrados con mayor frecuencia en los CNR de cáncer de próstata. Entre ellos se encuentran la leuprorelina, la goserelina y la bicalutamida, principios activos considerados dentro de la terapia hormonal. Estos agentes reducen las concentraciones de andrógenos o bloquean su acción, por lo que, en casos sensibles a la castración, impide la progresión del cáncer de próstata.

Es importante puntualizar que los datos presentados corresponden a las frecuencias de uso, es decir que no se tiene en cuenta el uso concomitante de uno o más fármacos, ni los medicamentos que, a pesar de estar reportados, no corresponden al tratamiento de elección para este tipo de cáncer.

Asimismo, de los casos de esta neoplasia registrados en los CNR con información de estadificación TNM disponible, 167 recibieron tratamiento de soporte con ácido zoledrónico y 69 con denosumab.

Figura 3.2. Distribución de los medicamentos prescritos con mayor frecuencia en los casos nuevos de cáncer de próstata en el marco del aseguramiento, Colombia 2025



Incluye cáncer *in situ* e invasivo y todas las edades.

Descargar figura

3.3. Caracterización de los casos prevalente de cáncer de próstata

A continuación, se describen las características sociodemográficas de los casos prevalentes de cáncer de próstata. El 72,72 % correspondió a afiliados del régimen contributivo y la mediana de la edad fue de 74 años (RIC: 68 - 80). Además, la mayoría de los casos en la población indígena pertenecía al subsidiado, mientras que el mayor número de casos con etnia negra pertenecía al contributivo.

Según el lugar de residencia, el 27,06 % del total de los casos se concentró en la región Central, patrón que también se observó en los regímenes contributivo y especial. En contraste, en el régimen subsidiado la mayor proporción de los casos se ubicó en la región Caribe, mientras que en el régimen de excepción el 24,76 % de los casos residían en Bogotá, D. C., **(tabla 3.11).**

Tabla 3.11. Caracterización sociodemográfica de los casos prevalentes de cáncer de próstata según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

Variables[1]	Régimen del aseguramiento						
	Contributivo	Subsidiado	Excepción	Especial	Planes voluntarios de salud	No asegurado	Total[2,3]
	n= 59.167	n= 15.881	n= 5.840	n= 389	n= 71	n= 19	n= 81.367
	(72,72 %)	(19,52 %)	(7,18 %)	(0,48 %)	(0,09 %)	(0,02 %)	(100,00 %)
Edad	74 (68 - 80)	75 (69 - 81)	74 (69 - 80)	77 (73 - 82)	69 (63 - 75)	75 (66 - 79)	74 (68 - 80)
Etnia							
Ninguna	58.005 (98,04)	15.308 (96,39)	5.655 (96,83)	388 (99,74)	71 (100,00)	19 (100,00)	79.446 (97,64)
Indígena	42 (0,07)	298 (1,88)	5 (0,09)	0 (0,00)	0 (0,00)	0 (0,00)	345 (0,42)
Negro	1.019 (1,72)	262 (1,65)	168 (2,88)	1 (0,26)	0 (0,00)	0 (0,00)	1.450 (1,78)
Otra[4]	101 (0,17)	13 (0,08)	12 (0,21)	0 (0,00)	0 (0,00)	0 (0,00)	126 (0,15)
Región de residencia							
Amazonía-Orinoquía	268 (0,45)	299 (1,88)	50 (0,86)	0 (0,00)	0 (0,00)	0 (0,00)	617 (0,76)
Bogotá, D. C.	15.881 (26,84)	1.212 (7,63)	1.446 (24,76)	44 (11,31)	37 (52,11)	1 (5,26)	18.621 (22,89)
Caribe	7.377 (12,47)	6.430 (40,49)	1.135 (19,43)	25 (6,43)	11 (15,49)	3 (15,79)	14.981 (18,41)
Central	17.358 (29,34)	3.090 (19,46)	1.391 (23,82)	162 (41,65)	11 (15,49)	9 (47,37)	22.021 (27,06)
Oriental	8.717 (14,73)	2.282 (14,37)	1.088 (18,63)	38 (9,77)	9 (12,68)	5 (26,32)	12.139 (14,92)
Pacífica	9.566 (16,17)	2.568 (16,17)	730 (12,50)	120 (30,85)	3 (4,23)	1 (5,26)	12.988 (15,96)

[1] Los valores reportados corresponden a frecuencias absolutas y relativas (n, %) para todas las variables, excepto la edad en la que se presenta la mediana (rango intercuartílico).
[2] El número total de casos prevalentes incluyen 71 casos de los planes voluntarios de salud y 19 en la población no asegurada.
[3] No se incluyeron los datos de 790 casos prevalentes, que no se reportaron en el periodo actual porque pertenecen a entidades liquidadas.
[4] Incluye población perteneciente a las etnias ROM (gitano), raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia y palenqueros de San Basilio.

3.4. Indicadores de gestión del riesgo en el cáncer de próstata

Los siguientes son los indicadores prioritarios para la medición, evaluación y monitoreo de la gestión del riesgo por parte de los aseguradores y prestadores en la población con cáncer de próstata en el marco del aseguramiento en Colombia (1):

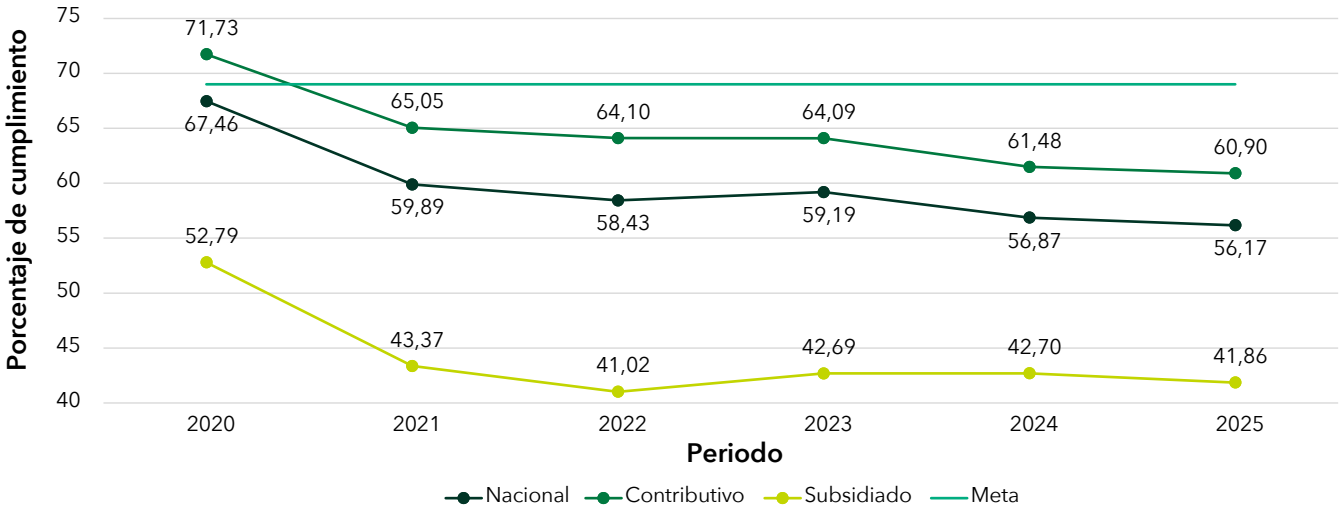
1. **Oportunidad de diagnóstico (en días):** tiempo entre la consulta donde se realiza la remisión por sospecha clínica o paraclínica, asociada al cáncer de próstata hasta el diagnóstico.
2. Proporción de pacientes con cáncer de próstata estadificados en TNM.
3. Proporción de pacientes con cáncer de próstata localizado (estadios 0, I y II).
4. Proporción de pacientes con cáncer de próstata localmente avanzado y avanzado (pacientes en estadios III y IV).
5. Proporción de pacientes estadificados en Gleason score.
6. **Oportunidad de tratamiento (en días):** tiempo entre el diagnóstico hasta el primer tratamiento.
7. Seguimiento de PSA postratamiento en cáncer de próstata.
8. Supervivencia global (5 años).
9. Calidad de vida.

Puede consultar los datos de la gestión del riesgo con una mayor desagregación ingresando a HIGIA.

Los resultados más recientes del indicador 8 se presentaron en el informe especial "Resultados de supervivencia global en las personas atendidas en el marco del sistema de salud colombiano y notificadas a la Cuenta de Alto Costo 2014-2022" (2). Por último, es de destacar que en el momento no se dispone de las variables necesarias para la evaluación del indicador 9.

Como se observa en la **figura 3.3,** desde el periodo 2020 se ha identificado una tendencia descendente en la proporción de casos nuevos localizados (0, I y II). Para el periodo 2025 se calculó el valor más bajo, por lo cual este indicador se mantuvo por debajo de la meta establecida. En el régimen contributivo se presentó una mayor proporción de casos nuevos en estadios localizados, mientras que en el subsidiado cerca de seis de cada diez casos fueron detectados en estadios avanzados.

Figura 3.3. Tendencia de la proporción de los casos nuevos localizados (estadios 0, I y II) en el momento del diagnóstico de cáncer de próstata en el marco del aseguramiento, Colombia 2020 - 2025

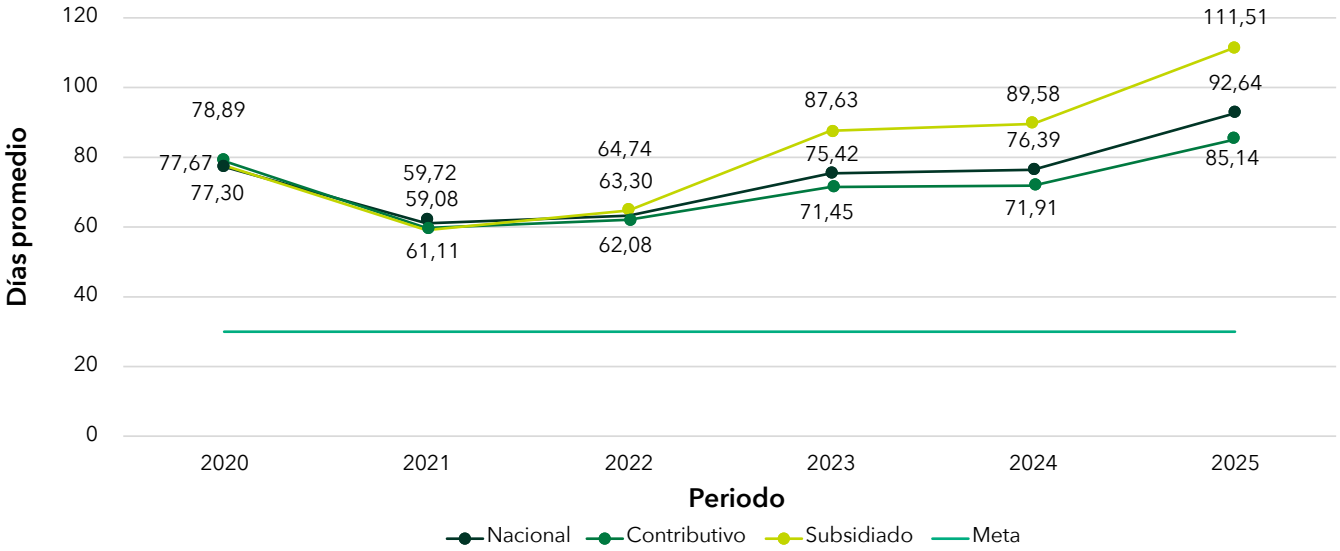


Incluye los estadios 0, I y II.

Descargar figura

El tiempo transcurrido entre la consulta por sospecha clínica y la confirmación diagnóstica ha aumentado en los últimos cuatro periodos. Particularmente, en comparación con el 2024, este periodo la medida incrementó en 16 días promedio. Por otro lado, los tiempos más prolongados se observaron en el régimen subsidiado, en donde la brecha con el contributivo ha venido incrementándose en los últimos tres periodos **(figura 3.4).**

Figura 3.4. Tendencia de la oportunidad de la confirmación diagnóstica de los casos nuevos de cáncer de próstata en el marco del aseguramiento, Colombia 2020 - 2025



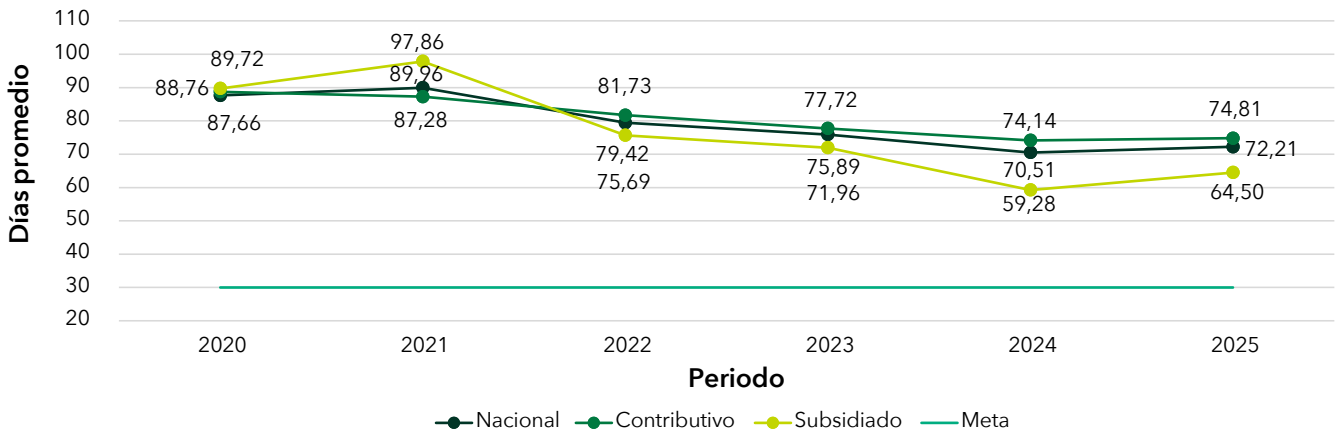
Incluye cáncer *in situ* e invasivo.
Oportunidad diagnóstica: tiempo entre la consulta por sospecha de síntomas y la confirmación diagnóstica.
La media (desviación estándar) para la oportunidad del diagnóstico en el 2025 fue: de 92,64 días (± 95,51) en la medición nacional, de 85,14 días (± 89,04) en el régimen contributivo y de 111,51 días (± 107,67) en el subsidiado.
La mediana (rango intercuartílico) para la oportunidad del diagnóstico en el 2025 fue: de 62 días (RIC: 31 - 119) en la medición nacional, de 59 días (RIC: 30 - 107) en el régimen contributivo y de 80 días (RIC: 35 - 153) en el subsidiado.

Descargar figura

En relación con el inicio del tratamiento, los tiempos de atención mostraron una tendencia descendente desde el 2021, alcanzando en el último periodo una oportunidad nacional similar a la observada en el 2024.

Entre los regímenes del aseguramiento, el subsidiado ha presentado de manera consistente menores tiempos de espera que el contributivo. No obstante, para el 2025 se observó un aumento en el promedio de días para el régimen subsidiado con un aumento de 5,22 promedio de días, respecto al periodo anterior **(figura 3.5).**

Figura 3.5. Tendencia de la oportunidad del inicio del tratamiento de los casos nuevos de cáncer de próstata en el marco del aseguramiento, Colombia 2020 – 2025



Incluye cáncer *in situ* e invasivo.
Oportunidad del tratamiento: tiempo entre el diagnóstico histológico y el primer tratamiento. La media (desviación estándar) para la oportunidad del tratamiento en el 2025 fue: nacional 72,21 días (± 55,86), contributivo 74,81 días (± 55,05), y subsidiado 64,50 días (± 56,07).
La mediana (rango intercuartílico) para la oportunidad del tratamiento en el 2025 fue: nacional 58 días (RIC: 31 - 99), contributivo 62 días (RIC: 34 - 102), y subsidiado 48,5 días (RIC: 22 - 92).

Descargar figura

La estadificación de pacientes con cáncer de próstata mostró, en todas las regiones del país **(tabla 3.12),** un cumplimiento entre el 60,00 % y el 90,00 %. Sin embargo, la proporción de pacientes clasificados en estadios localizados fue baja en la mayoría de las regiones, excepto en Bogotá, D. C., donde se alcanzó un cumplimiento intermedio en la detección temprana. De manera similar, Bogotá, D. C., presentó el mejor resultado en la identificación de casos nuevos en estadios localmente avanzados y avanzados (33,07 %), lo que la ubicó en un nivel de cumplimiento medio. En el resto de las regiones, este porcentaje superó el 37,00 % y se clasificó en un nivel de cumplimiento bajo.

En todas las regiones, la proporción de casos nuevos con clasificación de Gleason fue mayor al 90,00 %. Por su parte, la realización de al menos una medición del PSA dentro del primer año posterior al tratamiento alcanzó el 70,73 % en la región Central, seguida del Caribe con 68,97 %.

Tabla 3.12. Indicadores de gestión del riesgo en cáncer de próstata según la región de residencia en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

Número		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Código[1]		PRO_01	PRO_02	PRO_03	PRO_04	PRO_05	PRO_06	PRO_07
Semaforización		< 30 días	> 90%	> 69%	< 31%	> 90%	< 30 días	Por definir
		30 a < 60 días	60 a 90 %	> 62 a 69 %	31 a < 37 %	85 a 90 %	30 a < 60 días	
		≥ 60 días	< 60 %	≤ 62 %	≥ 37 %	< 85 %	≥ 60 días	
Región	Amazonía-Orinoquía	79,96	79,69	47,06	52,94	96,72	102,00	58,14
	Bogotá, D. C.	86,28	86,30	66,93	33,07	97,63	74,46	49,68
	Caribe	102,14	84,32	53,16	46,84	98,41	54,28	68,97
	Central	97,22	86,63	54,24	45,76	96,30	78,79	70,73
	Oriental	84,33	84,59	52,76	47,24	94,67	83,81	59,66
	Pacífica	87,58	84,01	49,64	50,36	94,72	82,83	64,19
Nacional		**92,64**	**84,59**	**56,17**	**43,83**	**96,70**	**72,21**	**63,19**

[1] Código del indicador en HIGIA.

Referencias bibliográficas

1. Cuenta de Alto Costo. Consenso basado en evidencia de indicadores de gestión del riesgo por parte de asegurado-res y prestadores en pacientes con cáncer de próstata en Colombia [en línea]. 2017. p. 1-44. Disponible en: https://cuentadealtocosto.org/site/publicaciones/consenso-basado-en-evidencia-para-la-definicion-de-indicadores-prio-ritarios-para-la-medicion-evaluacion-y-monitoreo-de-la-gestion-de-riesgo-por-parte-de-aseguradores-y-prestado-res-en-pacientes-con-ca/

2. Cuenta de Alto Costo (CAC), Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo. Informe especial: Resultados de supervivencia global en las personas atendidas en el marco del sistema de salud colombiano y notificadas a la Cuenta de Alto Costo, 2014-2022; Bogotá, D. C. 2025. Disponible en: https://cuentadealtocosto.org/publicaciones/informe-de-supervivencia-2014-2022/